ONEMA-POP-057 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

Manejo do Delirium Hiperativo e Agitação no Fim da Vida

1. Identificação institucional

2. Objetivo e abrangência

Padronizar avaliação, decisão, execução e comunicação no contexto de manejo do delirium hiperativo e agitação no fim da

vida, em atendimento domiciliar presencial ou remoto conforme aplicabilidade. Não substitui prescrição, avaliação médica

nem instruções do fabricante.

3. Competência, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado e capacitado; executar intervenções apenas no âmbito legal, da prescrição e do protocolo institucional.

Não realizar manipulação invasiva quando não houver indicação, treinamento, material adequado ou estabilidade clínica.

4. Materiais e fornecimento

Escala de desconforto, sinais vitais quando apropriados, ambiente seguro e plano paliativo. Equipamentos

profissionais/EPIs: enfermeiro ONEMA; consumíveis específicos: paciente/responsável, salvo ajuste contratual. Em visita

presencial, equipamentos de avaliação clínica conforme indicação.

5. Avaliação e preparo

Flutuação cognitiva, dor, retenção urinária, constipação, medicamentos, hipóxia e metas de cuidado. Confirmar identificação,

consentimento, alergias, medicamentos, ambiente, suporte disponível e condições para encaminhamento.

6. Execução técnica numerada

01. Confirmar plano de cuidados e objetivos previamente pactuados com paciente/família.

02. Avaliar início e flutuação da agitação e possíveis causas reversíveis de sofrimento.

03. Reduzir estímulos, favorecer presença familiar, comunicação calma e ambiente seguro.

04. Pesquisar dor, bexiga cheia, constipação, efeitos de medicamentos e outras causas conforme proporcionalidade.

05. Comunicar equipe paliativa para revisão terapêutica; não iniciar ou ajustar sedativos sem prescrição.

06. Se risco imediato de auto/heterolesão, garantir segurança e solicitar apoio urgente.

07. Reavaliar resposta a intervenções e possíveis efeitos adversos de tratamentos prescritos.

08. Registrar metas, avaliação, intervenções, resposta e alinhamento com família/equipe.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Agitação com risco imediato, sofrimento refratário ou suspeita de causa aguda tratável: escalonar. Na emergência, acionar

SAMU 192 e registrar o horário. Não insistir em procedimento inseguro.

8. Cuidados posteriores e orientações

Orientar familiares sobre delirium e sinais que exigem contato com equipe.

9. Carteira Digital ONEMA

Registrar data/hora, modalidade, identificação e consentimento, achados positivos e negativos, sinais vitais se pertinentes,

intervenção passo a passo, materiais/dispositivo quando aplicável, intercorrências, comunicação, encaminhamento,

orientações, plano de seguimento e identificação profissional.

10. Referências técnicas rastreáveis

NICE NG31 seção 1.5.23–1.5.28; NICE CG103 | Conferir aplicação integral ao cenário brasileiro e IFU específico antes de

liberação assistencial.

aplicativo.